



字号:   14

中国失眠症诊断和治疗指南、最新的欧洲指南、澳大利亚睡眠协会等相关指南都推荐，认知行为治疗（CBTI）是失眠的一线治疗方案，长期来看，CBTI的疗效优于药物疗法，如果患者积极配合，有效率可以达到80%。

CBT-I主要包括:

1) 认知治疗：培养对睡眠的正确认知。了解每个人需要的睡眠时间有差异，不要纠结于睡眠时长，入睡时间或夜间醒来30分钟内都是正常的，失眠没那么可怕。要避免对自我睡眠能力的担忧和焦虑，过度关注睡眠和努力睡眠反而会导致干扰睡眠的认知唤醒，加重失眠。

2) 睡眠卫生：建立一个良好的睡眠环境和睡眠习惯，减少干扰睡眠的外因。比如：避免睡前吸烟，喝酒、茶或咖啡，避免睡前兴奋性运动或玩游戏、看情节紧张视频等；定时作息，周末晚睡或晚起也不要超过平时时间的半小时；卧室环境要尽量避光、避免噪音、温度适中稍冷；抽空处理脑子里的问题，可以写下来，不要把这些问题带到卧室；不要在床上做和睡眠无关的活动，如看手机，电视，读书等；如果半夜醒来，不要看钟，继续睡。

3) 刺激控制疗法：只有感到瞌睡时才上床，不要在床上醒着，不要在床上做与睡觉无关的事。通过行为训练，切断“床=不睡觉”的旧反射，建立“床=睡觉”的新反射。上床后，如果15-20分钟还未入睡（期间不要反复看表），就果断离开卧室，去另外安静光线弱的房间做一些其他轻松的事情，等到有睡意的再回到床上（切断旧反射，同时消除难以入睡带来的挫折感），如果还睡不着，重复上一步；不管晚上几点睡觉，早上都设定好闹钟定时起床，不要赖床（有助于建立规律的睡眠节律）。

4) 睡眠限制疗法：睡眠效率就是实际睡眠时间/总卧床时间，比如，我晚上11点上床，大概12点睡着，早上7点钟醒，醒后立刻起床，估计睡眠时间为7小时，躺床时间8小时，我的睡眠效率是： $7/8=0.875$ ，87.5%。成人健康的睡眠效率应该在85%以上，如果低于85%要逐渐缩短躺床时间，减少在床上醒着的时间，禁止日间小睡，增加夜晚的睡眠驱动力。

5) 矛盾意念法: 通过在正常入睡时进行相反的意念控制, 努力让自己保持清醒, 转移患者对迫切入睡的错误关注, 从而降低患者试图入睡时经历的担忧和焦虑, 减少内源性唤醒, 结果会入睡更快。

6) 放松训练: 任何一种有效的放松技巧都可以用来减少肌肉紧张, 促进睡眠。具体方法包括冥想、正念、渐进式肌肉放松、呼吸技巧等等, 我们会在以后的主题中详细讲解。

我院神经内科设有睡眠障碍门诊，门诊时间为每周五下午，可在潞河医院官网、潞河医院微信公众号平台、114预约挂号。

(神经内科 王雪梅)

下一篇：[一例抗-M引起新生儿溶血症的思考](#)

分享到:  

相关科室

相关医生

相关文章

相关咨询

相关视频

相关疾病



神经内科

神经内科成立于1990年，目前是潞河医院重点学科，是首都医科大学神经疾病的临床、科研、教学基地。科室现有卒中中心、神经内科一病区、神经内科二病区三个病区，其中包含脑血管病、眩晕、变性病、癫痫等亚专业学组。现有一支专业性强、理论扎实、经验丰富、人才梯队结构合理的高凝聚力团队，医护人员90余名，主任医师5名，副主任医师12名，主治医师16名，主任护师1人，中级护师2人，博士8名(包括在读博士)，硕士29名。开放床位111张，其中卒中中心重症监护病房6张，年收治神经疾病患者3000余例。日均门诊量400余人次…

[网站首页](#) | [关于我们](#) | [来院路线](#) | [医院微博](#) | [网站地图](#) | [院内信箱](#) | [在线咨询](#) | [在线查询](#) | [版权声明](#) | [联系方式](#) | [隐私安全](#) | [帮助信息](#)

京ICP备10216567号 京卫计网审[2015]第0059号



京公网安备 11011202000199号

工信部链接: <https://www.beian.miit.gov.cn>

版权所有：首都医科大学附属北京潞河医院(潞河医院)

地址：北京市通州区新华南路82号 本网站已被访问29724732次

电话：010-69543901 医疗机构医保代码：12110001 技术支持：

